

PEPTIGENE

Guía de péptidos · Pérdida de peso y control metabólico

Esta guía reúne los péptidos de Peptigene en la categoría **pérdida de peso y control metabólico** (*agonistas de incretinas, amilina y péptidos metabólicos*). Para cada uno encontrarás qué es, cómo funciona, sus beneficios, las dosis habituales y mínimas, una duración de referencia y, de forma destacada, sus contraindicaciones y los criterios de aptitud.

Aviso importante · Léelo antes de continuar

Este documento es **informativo y educativo**. Los péptidos descritos deben utilizarse únicamente tras una evaluación y bajo la supervisión de un profesional de la salud. Varios requieren prescripción o se encuentran en investigación clínica y algunos no tienen dosis humana estandarizada. Antes de considerar cualquier protocolo, revisa las **contraindicaciones** de cada compuesto y confirma tu **aptitud médica**: no todas las personas son candidatas. Las dosis son rangos de referencia que deben individualizarse. Esta información no sustituye el consejo médico ni constituye una indicación de tratamiento.

PÉRDIDA DE PESO Y CONTROL METABÓLICO · Agonistas de incretinas, amilina y péptidos metabólicos

Semaglutida · Agonista GLP-1 · semanal

Qué es. Análogo del GLP-1 de aplicación semanal; molécula base de las terapias de pérdida de peso más usadas.

Cómo funciona. Potencia la insulina dependiente de glucosa, suprime el glucagón, ralentiza el vaciado gástrico y reduce el apetito a nivel hipotalámico.

Beneficios

- Pérdida de peso de ~15% del peso corporal.
- Mejor control glucémico (HbA1c).
- Beneficio cardiovascular y mejora de presión y lípidos.

Dosis habitual	0.25 → 1.0–2.4 mg/sem	Duración sugerida	Crónico; efecto pleno 12–16 sem
Dosis mínima	0.25 mg/sem	Vía	Subcutánea, semanal

Contraindicaciones. Carcinoma medular de tiroides o MEN2, pancreatitis, embarazo y lactancia; precaución digestiva.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con sobrepeso, obesidad o diabetes tipo 2, previa valoración médica.

PEPTIGENE

Guía de péptidos · Pérdida de peso y control metabólico

Tirzepatida · Doble agonista GIP/GLP-1 · semanal

Qué es. Doble agonista de los receptores GIP y GLP-1, con uno de los perfiles de eficacia más altos disponibles.

Cómo funciona. Activa a la vez GIP y GLP-1, con efecto sinérgico sobre saciedad, sensibilidad a la insulina y metabolismo de grasas.

Beneficios

- Pérdida de peso de ~20–22% del peso corporal.
- Control glucémico potente.
- Mejora de lípidos y presión arterial.

Dosis habitual	2.5 → 5–15 mg/sem	Duración sugerida	Crónico; efecto pleno ≥ 12 sem
Dosis mínima	2.5 mg/sem	Vía	Subcutánea, semanal

Contraindicaciones. Carcinoma medular de tiroides o MEN2, pancreatitis, embarazo y lactancia.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con obesidad o diabetes tipo 2 bajo control médico.

Retatrutida · Triple agonista GIP/GLP-1/glucagón · en fase 3

Qué es. Triple agonista (GIP, GLP-1 y receptor de glucagón) en investigación clínica avanzada; aún no aprobado.

Cómo funciona. Suma la activación del receptor de glucagón —que eleva el gasto energético y la oxidación de grasa— a los efectos GIP/GLP-1.

Beneficios

- La mayor pérdida de peso reportada (~24% a 48 sem, fase 2).
- Fuerte mejora metabólica global.
- Reducción de grasa hepática y visceral.

Dosis habitual	Escalada hasta 8–12 mg/sem (ensayos)	Duración sugerida	En estudio; 48+ sem
Dosis mínima	1–2 mg/sem	Vía	Subcutánea, semanal

Contraindicaciones. Mismo perfil que los GLP-1; al ser experimental, únicamente en contexto clínico.

¿Es apto para el tratamiento? Compuesto no aprobado; sólo bajo protocolo médico.

PEPTIGENE

Guía de péptidos · Pérdida de peso y control metabólico

Cagrilintida · Análogo de amilina de larga acción · semanal

Qué es. Análogo de la amilina que potencia a los GLP-1 al combinarse (CagriSema / IcoSema).

Cómo funciona. Agonista de los receptores de amilina en el área postrema; reduce el apetito por una vía complementaria a la del GLP-1.

Beneficios

- Hasta ~10.8% de pérdida de peso en monoterapia.
- Hasta ~25.2% combinada con semaglutida.
- Control del hambre por mecanismo aditivo.

Dosis habitual	0.3 → 2.4 mg/sem	Duración sugerida	Crónico; escalada de 12+ sem
Dosis mínima	0.3 mg/sem	Vía	Subcutánea, semanal

Contraindicaciones. Embarazo y lactancia; precaución digestiva. Evitar combinaciones sin control médico.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con obesidad, sola o combinada con un GLP-1, bajo supervisión.

Liraglutida · Agonista GLP-1 · diario

Qué es. Análogo del GLP-1 de aplicación diaria, predecesor de la semaglutida.

Cómo funciona. Mismo mecanismo incretina que la semaglutida, con una vida media más corta que exige dosis diaria.

Beneficios

- Pérdida de peso de ~5–8%.
- Control glucémico en diabetes tipo 2.
- Reducción del apetito.

Dosis habitual	0.6 → 3.0 mg/día	Duración sugerida	Crónico; diario
Dosis mínima	0.6 mg/día	Vía	Subcutánea, diaria

Contraindicaciones. Carcinoma medular de tiroides o MEN2, pancreatitis, embarazo.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con sobrepeso u obesidad; alternativa diaria a la semaglutida.

PEPTIGENE

Guía de péptidos · Pérdida de peso y control metabólico

Survodutida · Doble agonista GLP-1/glucagón · en investigación

Qué es. Doble agonista de GLP-1 y receptor de glucagón, en desarrollo clínico para obesidad y esteatohepatitis.

Cómo funciona. Combina la saciedad del GLP-1 con el aumento del gasto energético del glucagón.

Beneficios

- Pérdida de peso de ~19% en fase 2.
- Reducción de grasa hepática (MASH).
- Mejora metabólica.

Dosis habitual	Escalada semanal (ensayos)	Duración sugerida	En estudio
Dosis mínima	Dosis inicial baja	Vía	Subcutánea, semanal

Contraindicaciones. Perfil de incretinas; experimental, sólo en contexto clínico.

¿Es apto para el tratamiento? No aprobado; en evaluación clínica.

MOTS-c · Péptido mitocondrial · metabolismo

Qué es. Péptido derivado de la mitocondria que actúa como regulador metabólico y 'mimético del ejercicio'.

Cómo funciona. Activa la vía AMPK, mejora la sensibilidad a la insulina y el uso de glucosa y grasa como energía.

Beneficios

- Apoya la sensibilidad a la insulina.
- Favorece la resistencia y el rendimiento.
- Efecto metabólico tipo ejercicio.

Dosis habitual	5–10 mg, 2–3 veces/sem	Duración sugerida	Ciclos de 4–8 sem
Dosis mínima	5 mg/sem	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Datos clínicos limitados; evitar en embarazo y lactancia.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos activos con enfoque metabólico; experimental.

PEPTIGENE

Guía de péptidos · Pérdida de peso y control metabólico

AOD-9604 · Fragmento de GH · pérdida de grasa

Qué es. Fragmento modificado de la hormona de crecimiento (176-191) orientado a la lipólisis.

Cómo funciona. Estimula la degradación de grasa sin los efectos de la GH sobre glucosa o crecimiento.

Beneficios

- Favorece la pérdida de grasa localizada.
- No afecta la glucemia ni el IGF-1.
- Buen perfil de tolerancia.

Dosis habitual	300 mcg/día	Duración sugerida	Ciclos de 8–12 sem
Dosis mínima	300 mcg/día	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Evidencia clínica limitada; evitar en embarazo y lactancia.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con enfoque en pérdida de grasa; experimental.

Recuerda: el mejor resultado nace de un protocolo individualizado. Confirma tu aptitud, revisa contraindicaciones e interacciones, empieza siempre por la dosis mínima y ajusta con seguimiento profesional. — **Peptigene**